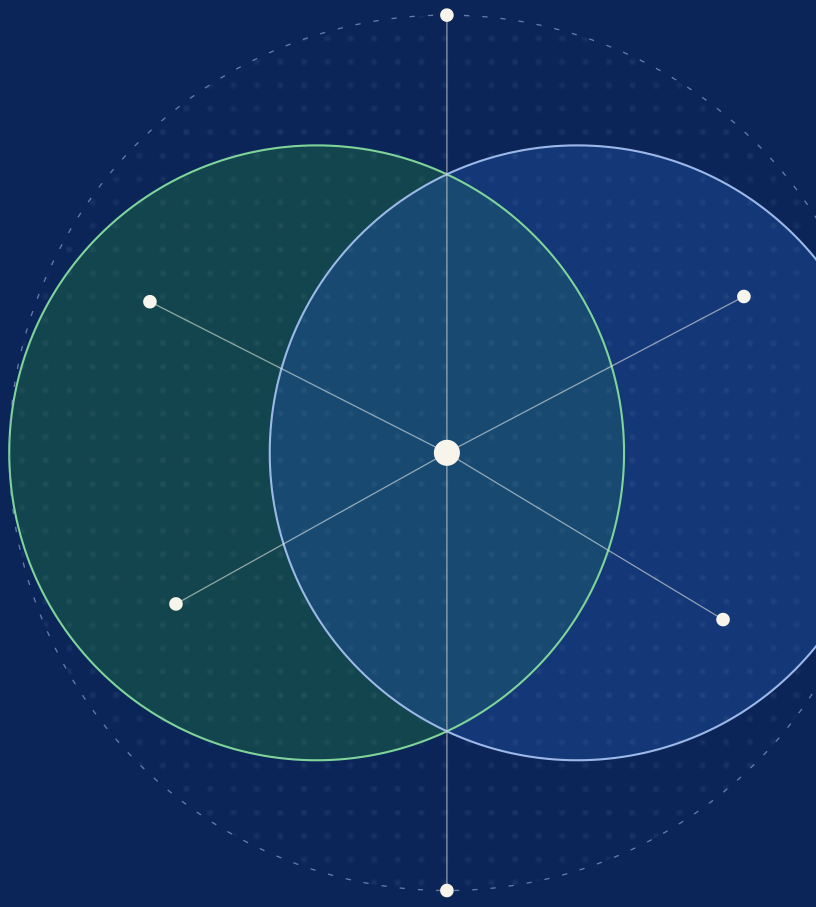


FIG. 0 — DEUX JURIDICTIONS, UN TERRITOIRE COMMUN
• MUTUELLE • CSU • COORDINATION

ARAILD · PLATEFORME MX-CONNECT

MX-CONNECT

De la solidarité mutualiste à la Couverture Santé Universelle

Une plateforme numérique qui modernise les mutuelles de santé, facilite l'orientation des populations vers la CSU et renforce la complémentarité entre les mécanismes communautaires et publics de protection sanitaire.

DESTINATAIRE
Ministère de la Santé Publique

DESTINATAIRE
Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale

DESTINATAIRE
Ministère de la Jeunesse et de l'Éducation Civique

L'ESSENTIEL EN TROIS PHRASES

01 La mutuelle protège ses membres selon ses propres garanties.

02 La CSU assure la couverture dans le cadre du dispositif national.

03 MX-CONNECT facilite la coordination et la complémentarité entre les deux.

Adhérer à une mutuelle ne vaut pas enrôlement à la CSU, et l'enrôlement à la CSU n'entraîne aucune adhésion à une mutuelle. MX-CONNECT préserve cette distinction. Il outille les mutuelles et en fait des partenaires communautaires d'information, d'orientation et d'accompagnement vers le dispositif national, sans jamais s'y substituer.

SOMMAIRE

Objet de la démarche et positionnement P. 03

I. Analyse situationnelle P. 04 - 08

II. La plateforme MX-CONNECT P. 09 - 10

III. Mutuelles et CSU : deux mécanismes distincts et complémentaires P. 11 - 16

IV. Contributions aux autres politiques publiques P. 17

V. Fonctionnement, écran par écran P. 18 - 21

VI. Sollicitations, feuille de route et indicateurs P. 22 - 23

Sources · Contact P. 24 - 25

OBJET DE LA DÉMARCHE

Un outil d'intérêt public au service des politiques déjà engagées

CE QUE N'EST PAS CETTE NOTE

Une offre commerciale. MX-CONNECT ne vend aucune prestation aux ministères et ne détient jamais de fonds.

CE QU'ELLE PROPOSE

Un instrument opérationnel, déjà en ligne, qui relie mutuelles de santé, formations sanitaires, organisations et citoyens.

CE QU'ELLE SOLLICITE

Un accompagnement institutionnel pour un pilote encadré, aligné sur la CSU, le PSNSN 2026-2030 et la protection sociale.

POSITIONNEMENT · TROIS FONCTIONS STRATÉGIQUES

FONCTION 1

Gestion mutualiste

Moderniser les mutuelles de santé communautaires et renforcer leur transparence financière et administrative : adhérents, cotisations, garanties, prestations, comptabilité SYSCOHADA.

FONCTION 2

Facilitation de la CSU

Mobiliser les mutuelles et les organisations communautaires pour informer, orienter et accompagner les populations vers l'enrôlement officiel, sans jamais s'y substituer.

FONCTION 3

Coordination de la protection sanitaire

Faciliter la complémentarité entre la CSU, les mutuelles et les formations sanitaires, en évitant les doubles facturations et en réduisant le reste à charge des ménages.

Précaution institutionnelle. La fonction 2 et l'accès à toute information relative à la CSU supposent une convention avec les administrations compétentes. Les données de santé et les données personnelles sont traitées conformément à la loi n° 2024/017 du 23 décembre 2024.

I · 1.1 — CONTEXTE GÉNÉRAL

Une population jeune et de plus en plus connectée

30,1 M
habitants estimés fin 2025

41,9 %
de la population utilise Internet (12,6 millions)

5,9 M
utilisateurs des réseaux sociaux

< 35 ans
l'âge de la grande majorité des Camerounais

La Stratégie Nationale de Développement 2020-2030 (SND30) place le capital humain au cœur de son pilier 2 : accès équitable aux soins, protection sociale et mise en place de la Couverture Santé Universelle d'ici 2030.

I · 1.2 — SANTÉ ET COUVERTURE SANTÉ UNIVERSELLE

Les ménages paient encore l'essentiel des soins

72,2 %
des dépenses courantes de santé payées directement par les ménages

< 5 %
de la population couverte par une assurance ou une mutuelle (estimations)

4,6 M
personnes enrôlées à la CSU, 5,8 M pré-enrôlées (avril 2026)

35 %
part des paiements directs visée en 2030 par la stratégie CSU

Phase 1 de la CSU lancée le 12 avril 2023 : enfants de 0 à 5 ans, femmes enceintes, VIH, tuberculose, hémodialyse. Densité médicale de 1,68 médecin pour 10 000 habitants ; la santé représente 5,5 % du budget de l'État. La CSU fonctionne aujourd'hui par voie réglementaire ; la loi CSU est en préparation.

Sources : DataReportal, Digital 2026 ; Afrobaromètre ; SND30 ; OMS, comptes nationaux de la santé ; OCDE ; MINSANTE (29/04/2026) ; stratégie CSU ; revue à mi-parcours de la SND30.

I · 1.3 — PROBLÈMES IDENTIFIÉS

Six obstacles à la couverture du risque maladie

01

Mutuelles gérées sur papier

Registres manuels, aucune donnée consolidée, gestion difficile à contrôler.

02

Droits invérifiables au guichet

La formation sanitaire ne sait pas si le patient est à jour : fraudes et refus de prise en charge.

03

Secteur informel peu protégé

La majorité des travailleurs n'a ni sécurité sociale ni couverture maladie.

04

Données en silos

Maturité de la santé numérique évaluée à 1,8 sur 5 en 2025 ; outils peu interopérables.

05

CSU encore mal connue

Conditions, démarches et avantages de la CSU restent peu compris au niveau communautaire.

06

Confiance à reconstruire

Une gestion financière peu traçable décourage l'adhésion et la cotisation régulière.

I · 1.4 — SANTÉ DIGITALE

L'État a fixé le cap : un écosystème intégré, interopérable et souverain

2020 - 2024

PSNSN 1

Adopté le 16 janvier 2020, doté de 11,3 milliards FCFA. Renforcement du système d'information sanitaire (DHIS2).

2026 - 2030

PSNSN 2

Lancé le 4 mars 2026, environ 29 milliards FCFA, huit axes prioritaires. Point de départ : maturité de 1,8 sur 5.

VISION 2030

Un écosystème unique

Intégré, interopérable, sécurisé, inclusif, centré sur le patient, avec la souveraineté des données de santé.

Les mutuelles communautaires restent le maillon le moins numérisé de cette chaîne. C'est là que MX-CONNECT intervient, en s'ouvrant aux normes nationales.

Sources : MINSANTE, PSNSN 2020-2024 et 2026-2030 ; PNPS 2017 ; BIT ; Health Data Collaborative.

I · 1.5 — PROTECTION SOCIALE

Étendre la protection sociale au-delà de l'emploi formel

11 %

de la population bénéficie d'au moins un programme de protection sociale (hors santé)

≈ 23 %

de couverture sociale à mi-parcours de la SND30

Les efforts engagés

- **Politique nationale de protection sociale** (décembre 2017), qui vise notamment un régime adapté au secteur informel.
- **Assurance volontaire de la CNPS** (décret de 2014), ouverte aux travailleurs indépendants et informels, au taux de 8,4 % du revenu déclaré.
- **Économie sociale** : la loi n° 2019/004 reconnaît la mutuelle comme personne morale de prévoyance et de solidarité.
- **Point d'attention** : aucun texte spécifique aux mutuelles de santé n'a été identifié ; un texte sur les mutuelles de sécurité sociale est évoqué dans la stratégie CSU.

I · 1.6 — JEUNESSE ET ENGAGEMENT CIVIQUE

Une jeunesse disponible, à orienter vers l'engagement utile

36 %

des 18-35 ans se déclarent sans emploi et en recherche active (Afrobaromètre, 2024)

Le cadre posé par le MINJEC

- Politique nationale de la jeunesse (2006).
- Stratégie nationale du volontariat (2015, avec le PNUD) et Programme national de volontariat.
- Agence du Service Civique National de Participation au Développement (ASCNPD).
- Conseil national de la jeunesse (2009) et Plan triennal spécial jeunes.

Des compétences, du temps et une forte présence sur le mobile : un potentiel considérable pour la sensibilisation à la CSU et le volontariat.

Sources : OCDE, Financement de la protection sociale au Cameroun ; revue SND30 ; PNPS 2017 ; CNPS ; loi n° 2019/004 ; Afrobaromètre 2024 ; MINJEC ; PNUD.

I · 1.7 — ENVIRONNEMENT ET TERRITOIRES

La loi appelle à la participation citoyenne ; les outils manquent

Loi-cadre n° 96/12

Du 5 août 1996 : principes de participation, d'information, de prévention et de subsidiarité.

Décentralisation

Le Code général des collectivités territoriales décentralisées (2019) donne un rôle aux communes.

Santé et environnement

Eau, assainissement, salubrité : la prévention passe par des actions locales souvent associatives.

I · 1.8 — LOIS ET TEXTES DE RÉFÉRENCE

Le cadre dans lequel MX-CONNECT s'inscrit

DOMAINE	TEXTES ET STRATÉGIES DE RÉFÉRENCE
Santé et CSU	Loi-cadre n° 96/03 du 4 janvier 1996 dans le domaine de la santé ; Stratégie sectorielle de santé 2016-2027 ; CSU lancée par voie réglementaire en 2023 ; loi CSU en préparation.
Santé numérique et données	PSNSN 2026-2030 ; loi n° 2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cybersécurité ; loi n° 2024/017 du 23 décembre 2024 relative à la protection des données personnelles, en vigueur depuis le 23 juin 2026 (création de l'APDP).
Protection sociale et mutualité	Politique nationale de protection sociale (2017) ; assurance volontaire CNPS (2014) ; loi n° 2019/004 du 25 avril 2019 régissant l'économie sociale ; loi n° 90/053 du 19 décembre 1990 sur la liberté d'association.
Jeunesse	Politique nationale de la jeunesse (2006) ; Stratégie nationale du volontariat (2015) ; ASCNPD ; Conseil national de la jeunesse (2009).
Environnement et territoires	Loi-cadre n° 96/12 du 5 août 1996 ; loi n° 2019/024 du 24 décembre 2019 portant Code général des CTD.
Développement	Stratégie nationale de développement 2020-2030 (SND30), pilier 2 « capital humain et bien-être ».

Numéros et dates à confirmer au Journal officiel avant diffusion.

I · 1.9 — OPPORTUNITÉS

Un moment favorable pour agir

La CSU est lancée

Des millions de personnes déjà enrôlées : il faut des relais de proximité pour informer, orienter et accompagner les autres.

Un nouveau plan numérique

Le PSNSN 2026-2030 démarre et réclame des outils interopérables et souverains.

Des règles claires sur les données

La loi n° 2024/017, en vigueur depuis juin 2026, fixe un cadre de confiance.

Le mobile partout

12,6 millions d'internautes et un usage massif du téléphone et du Mobile Money.

Une tradition de solidarité

Tontines, associations, mutuelles : des réseaux existants à outiller, pas à créer.

Une jeunesse prête à s'engager

Volontariat et service civique peuvent porter la sensibilisation et l'orientation.

NOTRE PROPOSITION

Le chaînon manquant entre les politiques publiques et les communautés

Un même outil pour moderniser les mutuelles, orienter les populations vers la CSU, vérifier les droits mutualistes au guichet et rendre visibles les initiatives qui améliorent la vie des populations.

II · 2.1 — PRÉSENTATION

Une plateforme, trois volets complémentaires

VOLET 1 · DISPONIBLE

Gestion des mutuelles

- Adhérents, ménages, ayants droit
- Cotisations, reçus, trésorerie
- Garanties, prestations, tiers payant
- Carte mutualiste à QR code
- Comptabilité SYSCOHADA, rapports
- Portail des formations sanitaires

VOLET 2 · À DÉVELOPPER

Orientation vers la CSU

- Information sur la CSU
- Repérage volontaire des non-enrôlés
- Orientation vers les points officiels
- Suivi des personnes orientées
- Statut CSU distinct du statut mutualiste
- Sous convention avec le MINSANTE

VOLET 3 · DISPONIBLE

Réseau d'initiatives

- Pages des mutuelles et associations
- Projets aux résultats vérifiés
- « Je m'engage », « Soutenir »
- Offres, volontariat, emplois
- Adhésion en ligne à une mutuelle
- Application Android, invitation

II · 2.2 — HUIT PRINCIPES QUI NE SE NÉGOCIENT PAS

PRINCIPE	TRADUCTION DANS LA PLATEFORME
Données cloisonnées	Chaque mutuelle dispose de son espace ; aucune ne voit les données d'une autre.
Secret médical	Aucune donnée médicale dans le réseau social ni dans les notifications.
Aucun fonds détenu	La plateforme n'encaisse ni ne transfère d'argent : elle trace les opérations.
Consentement réel	Documents versionnés, cases jamais pré-cochées, acceptations horodatées.
Double authentification	Code à usage unique obligatoire pour tout le personnel.
Contrôle à quatre yeux	Personne ne valide sa propre saisie ; rôles séparés et incompatibilités.
Comptes SYSCOHADA	Écritures, balance, bilan et journal d'audit consultables.
Chiffres honnêtes	Données réelles uniquement ; informations déclarées distinguées des informations vérifiées.

Plateforme en ligne : m.araild.com · application Android en bêta. La déclaration auprès de l'APDP reste à effectuer dans le cadre du pilote.

II · 2.3 — CONTRIBUTION À LA COUVERTURE SANTÉ UNIVERSELLE

Les mutuelles, partenaires communautaires de la CSU

Les mutuelles ne sont pas des structures d'enrôlement à la CSU. Elles sont des partenaires de mobilisation, d'information, d'orientation et d'accompagnement. Le tableau ci-dessous sépare ce que fait la mutuelle avec MX-CONNECT de ce qui reste du seul ressort du dispositif national.

OBJECTIF CSU	CE QUE FAIT LA MUTUELLE AVEC MX-CONNECT	CE QUI RELÈVE DU DISPOSITIF NATIONAL
Faire connaître la CSU	Information documentée des adhérents et de leurs familles	Contenu officiel, conditions d'éligibilité
Enrôler	Repérage volontaire des non-enrôlés, orientation, aide au dossier, suivi	Enrôlement, preuve d'enrôlement, activation des droits
Réduire les paiements directs	Garanties complémentaires, tiers payant mutualiste	Panier de soins CSU et tarification
Sécuriser les prises en charge	Vérification des droits mutualistes au guichet, journalisée	Vérification des droits CSU
Éviter les doublons	Règles de coordination, factures contrôlées, 4 yeux	Règles nationales de prise en charge
Piloter par les données	Indicateurs agrégés et anonymisés, après validation	Système national d'information
Rendre des comptes	Comptabilité SYSCOHADA, rapports d'activité	Contrôle et régulation

À retenir. MX-CONNECT ne remplace pas la plateforme nationale de la CSU, ne délivre aucune preuve d'enrôlement et ne transforme pas un adhérent en bénéficiaire de la CSU. Tout échange de données avec les dispositifs nationaux se fera dans le cadre défini par le MINSANTE.

Objectif de la stratégie CSU : ramener les paiements directs de 70 % à 35 % d'ici 2030.

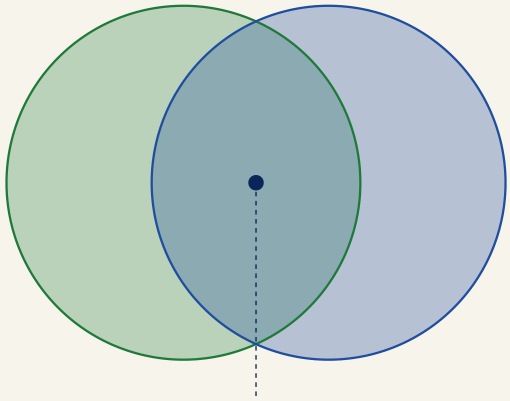
III · MUTUALITÉS DE SANTÉ ET COUVERTURE SANTÉ UNIVERSELLE

Deux mécanismes distincts et complémentaires

MUTUELLE DE SANTÉ

Démarche volontaire de solidarité

Un individu ou un ménage bénéficie des garanties définies par sa mutuelle, selon ses statuts, son règlement intérieur et la réglementation applicable.



COUVERTURE SANTÉ UNIVERSELLE

Dispositif national de l'État

Conditions, procédures et critères d'éligibilité définis par les autorités compétentes ; enrôlement selon les procédures officielles.

ZONE COMMUNE : COORDINATION ET COMPLÉMENTARITÉ

> Être membre d'une mutuelle ne signifie pas être enrôlé à la CSU.

> L'enrôlement à la CSU n'entraîne aucune adhésion à une mutuelle.

III · 3.1 — UNE COORDINATION ENTRE TROIS ACTEURS

A

Les mutuelles de santé communautaires

Elles protègent leurs membres et deviennent des relais de proximité.

B

Le dispositif national de la CSU

Il enrôle, délivre les droits et fixe les règles de prise en charge.

C

Les formations sanitaires et structures communautaires

Elles soignent, vérifient les droits et appliquent les règles de chaque couverture.

MX-CONNECT entend préserver cette distinction tout en facilitant la complémentarité entre les deux mécanismes.

III · 3.2 — DES PARCOURS D'ENREGISTREMENT INDÉPENDANTS

Trois parcours, jamais confondus

PARCOURS 1

Adhésion à une mutuelle

Libre et volontaire. La mutuelle fixe ses conditions, cotisations, garanties et modalités de prise en charge.

Le dossier mutualiste dans MX-CONNECT

- Identité de l'adhérent
- Composition du ménage
- Personnes à charge
- Date d'adhésion
- Cotisations versées
- Garanties souscrites
- Statut de la couverture mutualiste

L'adhésion ne donne pas automatiquement accès à la CSU.

PARCOURS 2

Enrôlement à la CSU

Démarche distincte, conforme aux procédures officielles des autorités compétentes.

Ce que MX-CONNECT peut faciliter

- Information et sensibilisation des populations sur la CSU.
- Identification volontaire des personnes non encore enrôlées.
- Orientation vers les points officiels d'enrôlement et aide à la constitution des dossiers.
- Suivi des personnes orientées.
- Vérification du statut d'enrôlement, lorsque l'accès au système officiel sera autorisé.
- Repérage des droits non activés ou à actualiser, selon les procédures officielles.

Limite. MX-CONNECT ne se substitue pas au système national d'enrôlement et ne délivre aucune preuve d'enrôlement CSU. La plateforme facilite l'orientation et le suivi, sous réserve d'un partenariat et d'une interconnexion autorisée.

PARCOURS 3

Coexistence des deux couvertures

C'est ici que MX-CONNECT apporte sa valeur ajoutée : chaque personne garde deux statuts séparés, et la plateforme aide à coordonner les prises en charge selon les règles de chaque dispositif. Les quatre situations possibles sont présentées page suivante.

III · 3.3 — MATRICE DES SITUATIONS

Chaque citoyen trouve sa place

Deux questions indépendantes suffisent à situer une personne. Pour chaque situation, MX-CONNECT a un rôle précis, sans jamais confondre les deux couvertures.

MEMBRE D'UNE MUTUELLE : OUI	ENRÔLÉ À LA CSU : OUI	ENRÔLÉ À LA CSU : NON
	3 **Membre d'une mutuelle et enrôlé à la CSU** Gestion distincte des deux couvertures ; coordination des prises en charge selon les règles applicables, sans double facturation.	1 **Membre d'une mutuelle uniquement** Gestion de sa couverture mutualiste et proposition volontaire d'orientation vers la CSU.
MEMBRE D'UNE MUTUELLE : NON	2 **Enrôlé à la CSU uniquement** Suivi de son statut CSU, sous convention, et information sur les possibilités de protection complémentaire.	4 **Ni membre d'une mutuelle, ni enrôlé à la CSU** Sensibilisation, orientation vers la CSU et information sur les mutuelles disponibles.

Inclusion. Les personnes qui ne souhaitent pas adhérer à une mutuelle ne sont pas exclues : elles peuvent bénéficier de la CSU.

Rigueur. Les adhérents d'une mutuelle ne sont jamais considérés comme couverts automatiquement par la CSU.

III · 3.4 — COMMENT LES MUTUELLES PEUVENT ACCÉLÉRER LA CSU

Cinq fonctions de relais communautaire

01	**Relais d'information**	Proches des ménages, les mutuelles informent sur les conditions d'accès à la CSU, les démarches d'enrôlement et les avantages de la couverture.
02	**Points d'orientation vers l'enrôlement**	À l'adhésion, le gestionnaire propose de vérifier séparément le statut CSU ; si la personne n'est pas enrôlée, elle est orientée vers le dispositif officiel. Démarche volontaire, qui ne conditionne jamais l'adhésion.
03	**Relais vers les populations vulnérables**	Repérage des personnes qui ont des difficultés d'accès aux soins — ménages à faibles revenus, travailleurs de l'informel, personnes éloignées des formations sanitaires — et orientation vers les mécanismes publics auxquels elles sont éligibles.
04	**Complémentarité financière**	Selon leurs capacités et leurs règlements, les mutuelles peuvent proposer des garanties complémentaires : – prestations non prises en charge par la CSU ; – frais restant à la charge du patient, lorsque c'est autorisé ; – prévention et accompagnement ; – assistance sanitaire et solidarité communautaire. Des règles de coordination évitent la double facturation et le double remboursement d'une même prestation.
05	**Données communautaires pour le pilotage**	Des données agrégées, après validation des indicateurs et des modalités de transmission par le MINSANTE : – adhérents des mutuelles ; personnes déclarant être enrôlées ; – personnes non enrôlées ; personnes orientées ; – enrôlements effectivement confirmés ; – difficultés d'accès à la couverture sanitaire.

III · 3.5 — UN SUIVI DIFFÉRENCIÉ DES DEUX STATUTS

Deux dossiers, deux sources de vérité

A · STATUT MUTUALISTE

Géré par la mutuelle

- Numéro d'adhésion
- Mutuelle de rattachement
- Ayants droit
- Cotisations
- Garanties
- Statut de la couverture mutualiste

B · STATUT CSU · ESPACE DISTINCT

Documenté sous convention

NON ENRÔLÉE

EN COURS DE DÉMARCHE

ENRÔLEMENT CONFIRMÉ

À ACTUALISER OU À VÉRIFIER

Seul le dispositif officiel, ou une vérification autorisée, peut confirmer un enrôlement.

Déclaré ≠ confirmé. Les informations non vérifiées (« la personne déclare être enrôlée ») sont toujours affichées et comptées séparément des données officiellement confirmées.

III · 3.6 — COMPLÉMENTARITÉ DES PRISES EN CHARGE

Renforcer la protection financière sans double facturation

Lorsqu'une personne bénéficie des deux mécanismes, les modalités de prise en charge sont définies par les conventions, les garanties mutualistes et les règles nationales de la CSU. La complémentarité peut porter sur :

i. les prestations complémentaires ;

ii. les frais restant éventuellement à la charge du patient ;

iii. les services non couverts par l'un ou l'autre mécanisme, dans les limites autorisées.

Objectif : renforcer la protection financière des ménages, éviter les doubles facturations et réduire les dépenses directes de santé.

Le module « statut CSU » et les règles de coordination sont des fonctions à développer pendant le pilote, avec les services compétents.

III · 3.7 — UNE CONTRIBUTION MESURABLE À L'EXTENSION DE LA CSU

Ce que MX-CONNECT ambitionne de faire progresser

Connaissance — accroître la connaissance de la CSU au niveau communautaire.

Orientation — faciliter l'accès aux mécanismes officiels d'enrôlement.

Barrières — réduire les obstacles administratifs et informationnels.

Suivi — mieux suivre les personnes orientées jusqu'à la confirmation.

Données — produire des données agrégées sur les besoins et les difficultés d'accès.

Complémentarité — renforcer le lien entre protection publique et solidarité mutualiste.

POSITIONNEMENT INSTITUTIONNEL

MX-CONNECT ne crée pas un régime parallèle de CSU et ne transforme pas les adhérents des mutuelles en bénéficiaires automatiques de la CSU.

La plateforme est un outil numérique d'appui à la mobilisation communautaire, à la gestion mutualiste, à l'orientation vers le dispositif national et au suivi de la complémentarité des mécanismes de protection sanitaire.

Condition de mise en œuvre. L'accès aux informations CSU, la vérification des enrôlements et toute interconnexion des systèmes nécessitent une convention avec les administrations compétentes. Les données de santé et les données personnelles sont traitées conformément à la réglementation en vigueur.

IV · 4.1 — SANTÉ DIGITALE (PSNSN 2026-2030)

Numériser le maillon communautaire, en s'ouvrant à l'écosystème national

DISPONIBLE AUJOURD'HUI

- Dossier numérique de l'adhérent et de ses ayants droit
- Carte mutualiste à QR signé, lue par caméra ou photo
- Portail des formations sanitaires conventionnées
- Factures PDF contrôlées, exports CSV
- Application Android et site mobile

À CONSTRUIRE AVEC LE MINSANTE

- Suivi différencié des statuts mutualiste et CSU
- Échange sécurisé avec la plateforme nationale de la CSU
- Indicateurs agrégés et anonymisés vers DHIS2
- Référentiel national des formations sanitaires
- Normes d'interopérabilité et d'hébergement du PSNSN

IV · 4.2 — PROTECTION SOCIALE, JEUNESSE, ENVIRONNEMENT

Le réseau social au service de trois politiques publiques

MINTSS

Protection sociale

- Mutuelles accessibles au secteur informel
- Cotisations traçables : échéanciers, reçus, relevés
- Gestion transparente, contrôlable par les membres
- Passerelle d'information vers l'assurance volontaire CNPS (à étudier)

MINJEC

Jeunesse

- « Je m'engage » : bénévolat, compétences, relais
- Offres de volontariat, de stages et d'emplois
- Jeunes ambassadeurs de la CSU et de la mutualité
- Invitation des proches par WhatsApp

TERRITOIRES

Environnement

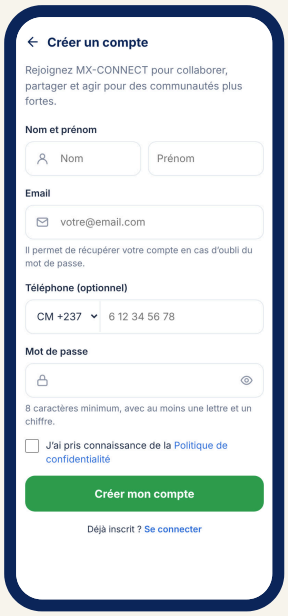
- Domaine « Environnement » parmi les domaines
- Projets aux résultats déclarés puis vérifiés
- Mobilisation de volontaires et de partenaires
- Visibilité des actions locales pour les communes

V · 5.1 — LE CITOYEN

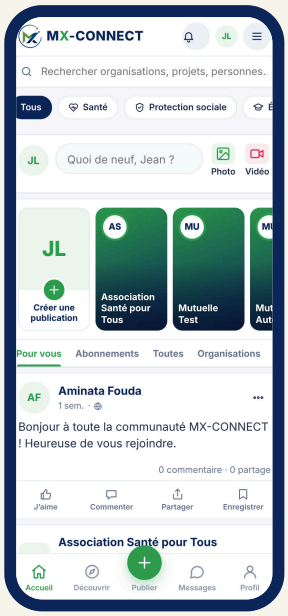
Ouvrir l'application, créer son compte, suivre l'actualité



Démarrage · contrôle de version et orientation



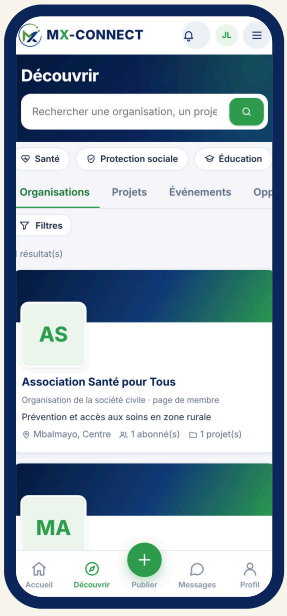
Inscription · e-mail ou téléphone, consentement explicite



Accueil · actualités, recherche, domaines

V · 5.2 — LES INITIATIVES

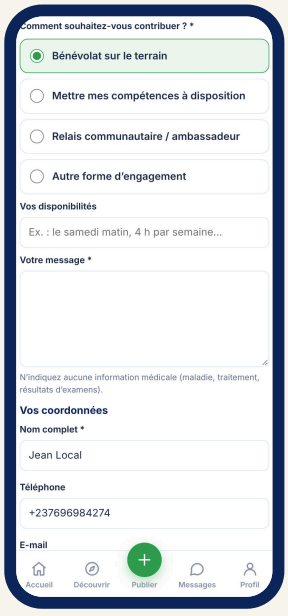
Découvrir un projet, voir ses résultats, s'engager



Découvrir · organisations, projets, filtres



Résultats · déclarés, puis vérifiés sur pièces

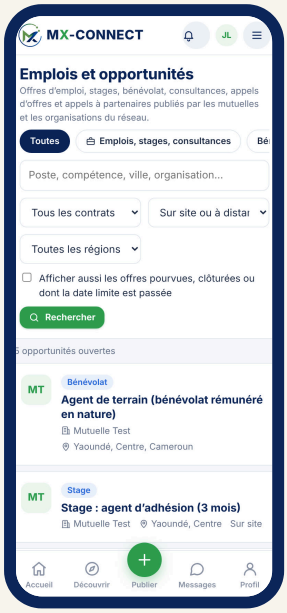


Je m'engage · bénévolat, compétences, relais

Captures réalisées sur une copie de test de la plateforme, avec des données fictives.

V · 5.3 — JEUNESSE ET MOBILISATION

Trouver une opportunité, gérer son espace, inviter ses proches



Opportunités · volontariat, stages, emplois



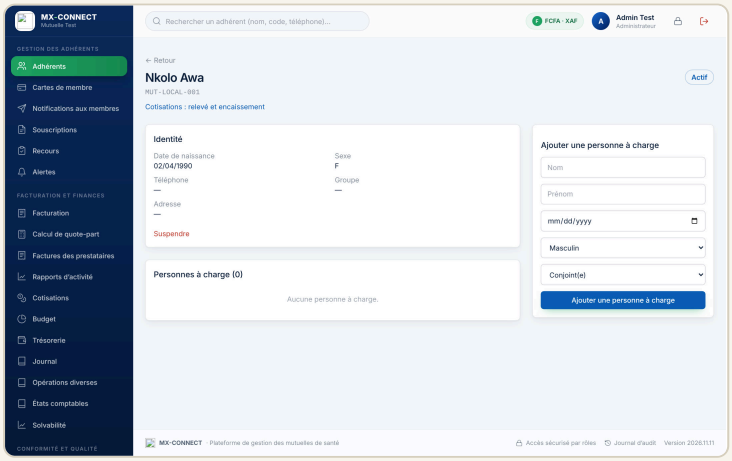
Mon profil · publications, groupes, demandes

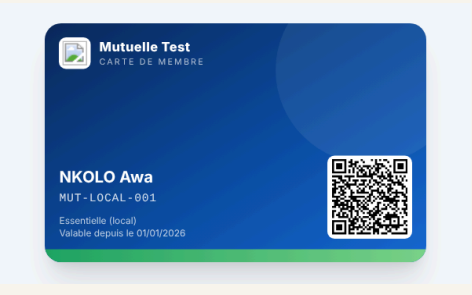


Inviter un ami · WhatsApp, Facebook, SMS

V · 5.4 — LA MUTUELLE : ADHÉRENTS ET CARTE MUTUALISTE

Enregistrer les adhérents, remettre une carte mutualiste vérifiable

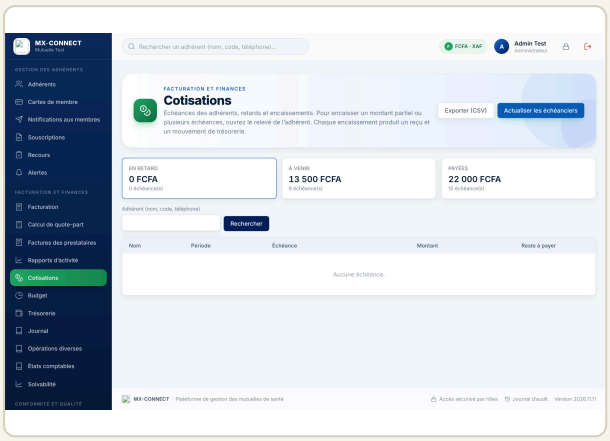




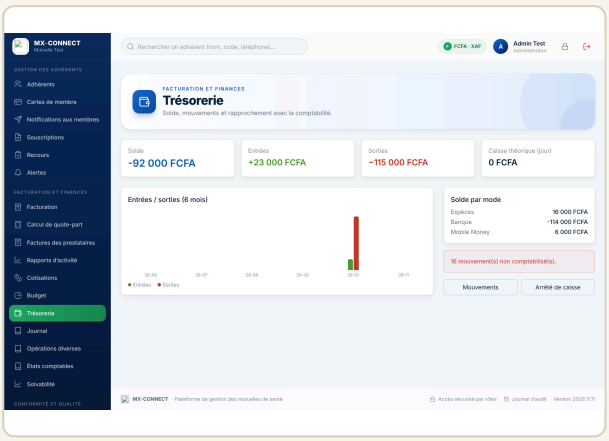
Carte mutualiste, pas carte CSU. Elle atteste uniquement l'adhésion à la mutuelle et ses garanties ; elle ne prouve aucun enrôlement à la CSU.

V · 5.5 — COTISATIONS ET TRÉSORERIE

Chaque franc encaissé est tracé, reçu à l'appui



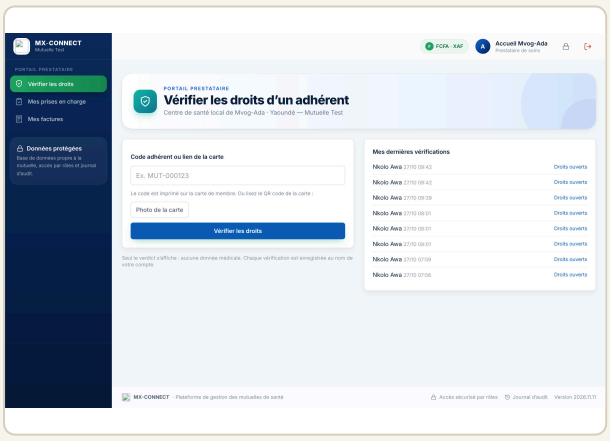
Cotisations · échéanciers, retards, encaissements partiels, reçu unique



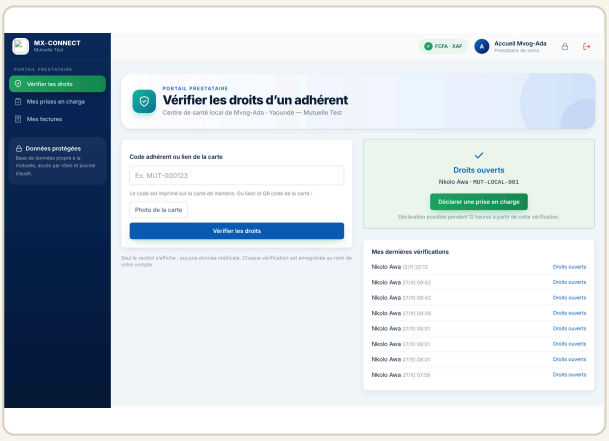
Trésorerie · caisse, banque, Mobile Money, arrêté de caisse

V · 5.6 — LA FORMATION SANITAIRE

Vérifier les droits mutualistes en quelques secondes



1. Lecture de la carte (caméra ou photo) ou saisie du code

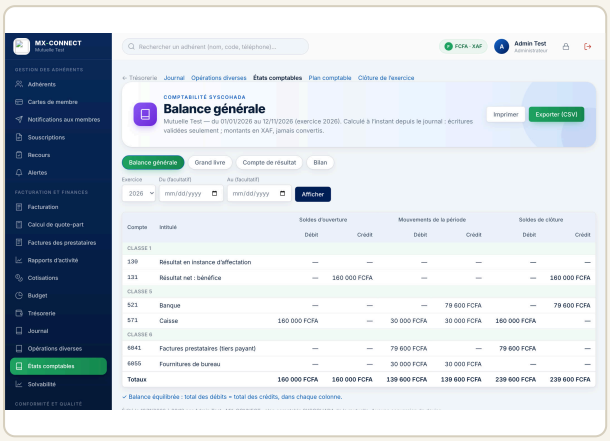


2. Réponse « droits ouverts », puis déclaration de la prise en charge

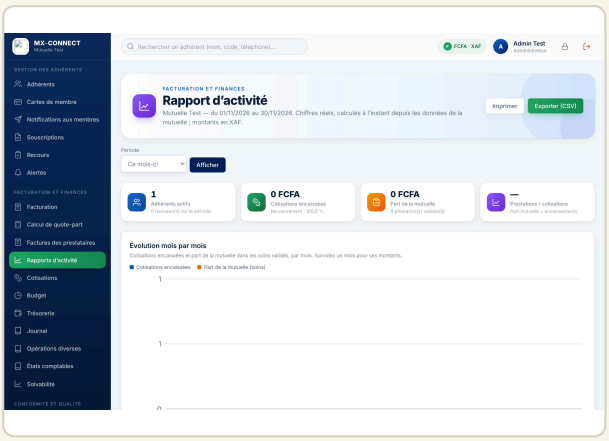
> **Droits mutualistes ≠ droits CSU.** Le portail vérifie aujourd'hui les seuls droits mutualistes. La vérification des droits CSU relève du dispositif national ; la coordination entre les deux sera définie avec le MINSANTE.

V · 5.7 — REDEVABILITÉ

Des comptes SYSCOHADA et des rapports prêts à transmettre



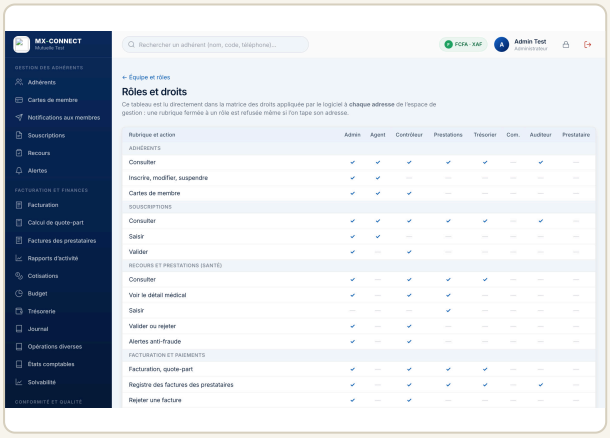
États comptables · balance, grand livre, résultat, bilan, clôture



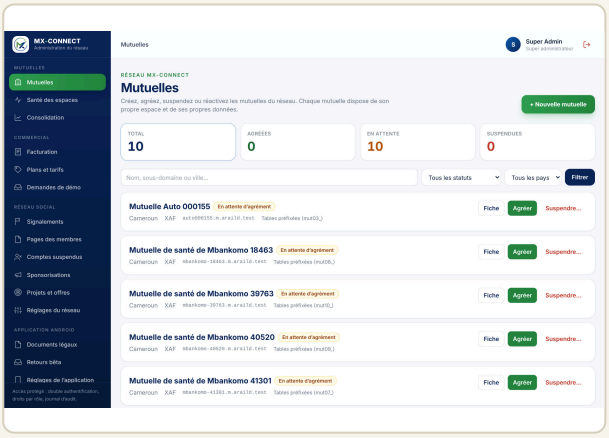
Rapports d'activité · adhérents, cotisations, prestations, évolution

V · 5.8 — GOUVERNANCE

Des rôles séparés dans chaque mutuelle, une supervision du réseau



Rôles et droits · agent, contrôleur, trésorier, auditeur, prestataire



Espace réseau · création, agrément, suspension des mutuelles

Captures réalisées sur une copie de test de la plateforme, avec des données fictives.

VI · 6.1 — CE QUE NOUS SOLLICITONS

Un cadre, un pilote et une caution technique

Aucune demande d'achat. Nous proposons une convention de partenariat et un comité technique conjoint, avec un point focal par ministère, l'ARAILD et des représentants des mutuelles.

MINSANTE

Santé publique

- Reconnaissance de MX-CONNECT comme outil de gestion mutualiste et d'orientation communautaire vers la CSU.
- Convention précisant l'accès aux informations CSU, la vérification des enrôlements et l'interconnexion.
- Accès aux normes d'interopérabilité du PSNSN et validation des indicateurs.
- Pilote dans un district de santé, avec ses formations sanitaires.

MINTSS

Travail et sécurité sociale

- Appui à la structuration des mutuelles du secteur informel.
- Étude d'une passerelle d'information avec l'assurance volontaire de la CNPS.
- Contribution aux réflexions sur le cadre juridique de la mutualité.

MINJEC

Jeunesse et éducation civique

- Diffusion auprès du Conseil national de la jeunesse et des associations.
- « Je m'engage » comme canal du volontariat, avec l'ASCNPD.
- Formation de jeunes ambassadeurs de la CSU et de la mutualité.

L'environnement (MINEPDED, communes) pourra être associé dans un second temps.

VI · 6.2 — FEUILLE DE ROUTE PROPOSÉE

Un pilote de 18 mois, mesuré et évalué

MOIS 0 - 3 · CADRAGE

- Convention et comité technique
- Choix du district et de [__] mutuelles
- Déclaration auprès de l'APDP
- Spécification du module « statut CSU »

MOIS 3 - 12 · PILOTE

- Formation des gestionnaires
- Adhésions et cartes mutualistes
- Sensibilisation et orientation vers la CSU
- Vérification des droits dans [__] formations sanitaires

MOIS 12 - 18 · ÉVALUATION

- Évaluation conjointe
- Interopérabilité avec la CSU
- Décision d'extension

VI · 6.3 — INDICATEURS DU PILOTE

INDICATEUR	DÉFINITION
Adhérents enregistrés · taux de recouvrement	Gestion mutualiste : adhérents actifs et cotisations encaissées / dues.
Vérifications de droits · prises en charge tracées	Opérations journalisées au guichet des formations sanitaires.
Membres sensibilisés à la CSU	Personnes ayant reçu une information documentée sur la CSU.
Personnes identifiées comme non enrôlées	Statut de non-enrôlement établi ou confirmé selon les modalités autorisées.
Personnes orientées vers l'enrôlement	Personnes ayant reçu une orientation documentée.
Enrôlements CSU confirmés	Confirmation issue du dispositif officiel ou d'une vérification autorisée.
Taux de confirmation des enrôlements	Enrôlements confirmés / personnes orientées × 100.
Personnes couvertes par les deux mécanismes	Adhésion mutualiste et enrôlement CSU tous deux confirmés.
Jeunes engagés · projets aux résultats vérifiés	Volet citoyen et mobilisation communautaire.

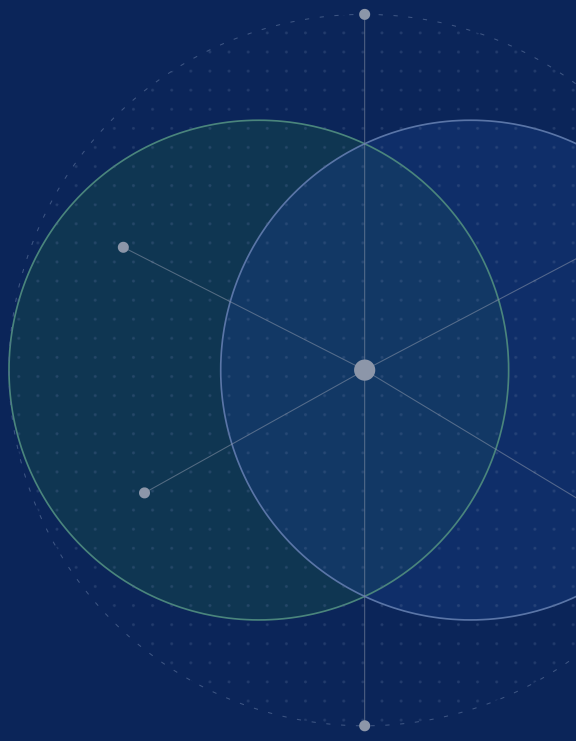
Règle de comptage. Une personne simplement orientée n'est jamais comptée comme enrôlée. Les cibles [__] sont à fixer avec le comité technique.

ANNEXE — SOURCES

Sources consultées

DONNÉE	SOURCE
Population, Internet, réseaux sociaux	DataReportal, *Digital 2026 : Cameroon*
Jeunesse, emploi des 18-35 ans	Afrobaromètre, dépêche AD1222 (2026), enquête 2024
Part des paiements directs (72,2 %)	OMS, comptes nationaux de la santé ; L'Économie ; OCDE (≈ 70 % en 2021)
Couverture assurance et mutuelles	Estimations de presse et d'études (1 à 5 %) ; BIT, diagnostic de la protection sociale
CSU : lancement, enrôlement	MINSANTE ; OMS AFRO ; point du Ministre de la Santé du 29 avril 2026 ; stratégie de développement de la CSU
Santé numérique	MINSANTE, PSNSN 2020-2024 et PSNSN 2026-2030 ; Health Data Collaborative
Protection sociale	OCDE, *Financement de la protection sociale au Cameroun* ; PNPS (2017) ; CNPS
SND30, revue à mi-parcours	Journal du Cameroun ; documents de la SND30
Données personnelles	Loi n° 2024/017 du 23 décembre 2024 ; presse spécialisée sur son entrée en vigueur
Économie sociale	Loi n° 2019/004 du 25 avril 2019
Jeunesse et volontariat	MINJEC, Politique nationale de la jeunesse ; PNUD, Stratégie nationale du volontariat
Environnement	Loi n° 96/12 du 5 août 1996 (FAOLEX) ; loi n° 2019/024

Avertissement. Les chiffres sont cités tels que publiés par leurs sources, qui ne mesurent pas toujours la même chose. Les références juridiques sont à confirmer au Journal officiel avant toute diffusion officielle.



EN CONCLUSION

Outiller les communautés pour que la protection sanitaire atteigne chaque foyer.

- La mutuelle protège ses membres selon ses propres garanties.
- La CSU assure la couverture dans le cadre du dispositif national.
- MX-CONNECT facilite la coordination et la complémentarité entre les deux.

MX-CONNECT est prêt à être mis à l'épreuve, sous l'autorité des ministères, dans un cadre transparent, conventionné et évalué.

PORTEUR

ARAILD · Lefankong Belmond, fondateur

CONTACT

m.araild.com · [téléphone] · [e-mail]